Opioides intranasales vs. morfina IV en el dolor agudo: ¿igual de eficaces y seguros?

Fida L, Alahmed H, Almutairi AS, AlNassar SY, Alanazi SA, Martan R, Al Sagel A, Almojaly LS, et al. Comparative efficacy and safety of intranasal opioids vs. intravenous morphine for acute moderate-to-severe pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Emerg Med*. 2026;91:158–172. doi:10.1016/j.jemermed.2026.09.021

Versión 1.0 · Revisado el 7 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Sí, cuando no hay vía IV
Apoya el fentanilo o el sufentanilo intranasal como alternativa sin aguja en el prehospitalario, en urgencias saturadas y en niños, cuando canalizar retrasa la analgesia.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Para la eficacia, razonable
ECA en su mayoría de bajo riesgo de sesgo y sin heterogeneidad. Pero el desenlace principal se basa en 4 a 5 ensayos (406 a 556 pacientes), no en los 1164 del total.

CUIDADO AL INTERPRETAR
"Sin diferencia" no es "igual"
No fue un análisis de no inferioridad. Y la seguridad es imprecisa: los eventos graves tuvieron un RR de 1.87 (0.97–3.59) y p = 0.06.

En 30 segundos. Metaanálisis de 10 ECA (1164 pacientes, adultos y niños) que compararon **opioides intranasales** (fentanilo en 5, sufentanilo en 3, morfina en 2) con **morfina IV** en dolor agudo moderado a grave: urgencias, prehospitalario, procedimientos y posoperatorio. La reducción del dolor fue similar a los **20 minutos** (DME −0.05; IC 95 % −0.24 a 0.14; 5 ensayos, 556 pacientes) y a los **30 minutos** (DME −0.05; −0.24 a 0.15; 4 ensayos, 406 pacientes). El rescate analgésico también fue similar (RR 1.00; 0.81–1.25). No hubo diferencias significativas en eventos adversos, aunque los **graves** rozaron la significancia (RR 1.87; 0.97–3.59) y la **disgeusia** aumentó de forma limítrofe con la vía nasal (RR 2.74; 1.00–7.49; p = 0.05). En un ensayo prehospitalario (PreMeFen, Lancet 2025), el fentanilo intranasal **no alcanzó la no inferioridad a los 10 minutos**.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cómo leer un "no hubo diferencia": la diferencia de medias estandarizada, por qué un metaanálisis de superioridad no demuestra equivalencia, cuántos pacientes respaldan en realidad cada desenlace, y por qué la ausencia de diferencias en eventos raros es casi siempre falta de precisión.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos y niños con dolor agudo moderado a grave en urgencias (incluidas pediátricas), ambulancias, procedimientos (drenaje de abscesos) y posoperatorio dental, ortopédico u otorrinolaringológico; fracturas y dolor cardiaco y no cardiaco. Cinco países: EE. UU., Australia, Bélgica, Noruega y Francia.
INTERVENCIÓN	Opioide intranasal: fentanilo (5 ensayos), sufentanilo (3) o morfina (2), con dosis y esquemas de repetición distintos entre estudios.
COMPARADOR	Morfina IV.
DESENLACES	Primario: cambio del dolor respecto a la basal a los 20 y 30 minutos. Secundarios: rescate analgésico y eventos adversos (cualquiera, graves, respiratorios, hemodinámicos, gastrointestinales, neurológicos y locales).

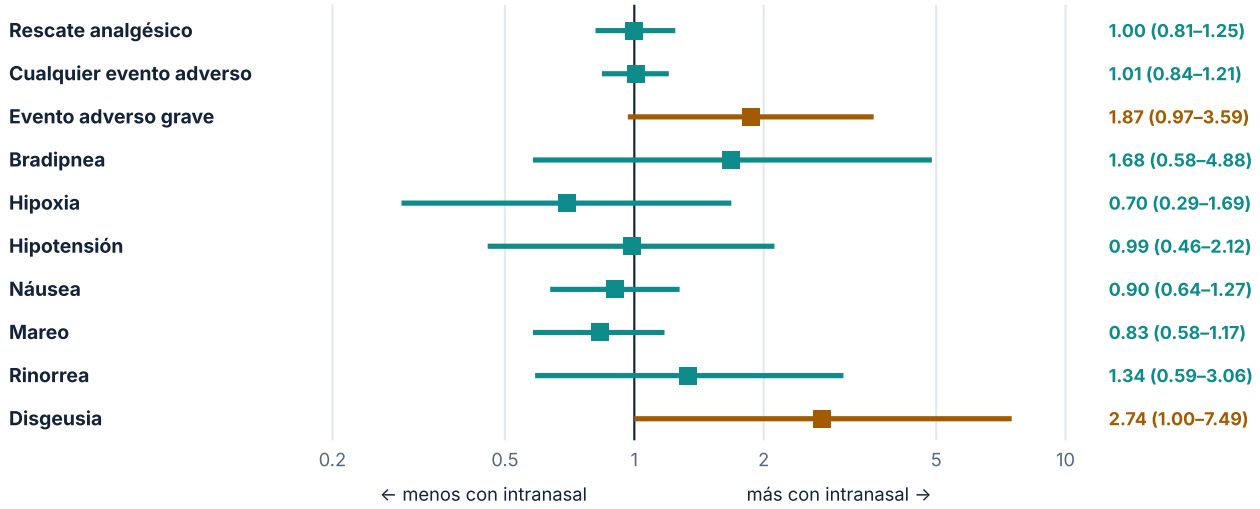
2 Diseño

BÚSQUEDA	PubMed, Scopus, Web of Science y Cochrane hasta mayo de 2026; 645 registros, 25 a texto completo y 10 ECA incluidos. Selección y riesgo de sesgo (RoB 2) por pares independientes.
ESTADÍSTICA	Efectos aleatorios. El dolor se combinó como diferencia de medias estandarizada (DME), porque los ensayos usaron escalas distintas. Hubo análisis de dejar uno fuera, gráficos de Galbraith y evaluación de efectos de estudios pequeños (Doi/LFK). Algunos datos se extrajeron de gráficas o se convirtieron desde medianas.
RIESGO DE SESGO	8 de 10 ECA con riesgo bajo; 2 con algunas dudas.
FINANCIAMIENTO	Sin financiamiento específico.

3 Resultados

DOLOR (CAMBIO RESPECTO A LA BASAL)	ENSAYOS (PACIENTES)	DME (IC 95 %)	I^2
20 minutos	5 (556)	**−0.05 (−0.24 a 0.14)**	11.9 %
Fentanilo / sufentanilo, 20 min	—	0.001 (−0.25 a 0.25) / −0.10 (−0.48 a 0.28)	0 % / 50 %
30 minutos	4 (406)	**−0.05 (−0.24 a 0.15)**	0 %

Intranasal vs. morfina IV: RR (IC 95 %) de rescate y seguridad



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto del artículo; no reproduce figuras originales. En ámbar, los dos resultados en el límite de la significancia.

4 Cómo leer estos resultados

- **La DME es pequeña, y el intervalo también.** DATO DEL ARTÍCULO −0.05 desviaciones estándar, con un IC que va de −0.24 a 0.14. INTERPRETACIÓN Por convención, 0.2 es un efecto "pequeño". El intervalo excluye diferencias moderadas o grandes en cualquier sentido, lo que apoya una eficacia comparable a los 20 y 30 minutos. Pero ese intervalo se basa en 4 o 5 ensayos, no en los 10.
- **"Sin diferencia" no es "equivalente".** INTERPRETACIÓN El análisis buscó diferencias, no fijó un margen de no inferioridad. De los ensayos de no inferioridad incluidos, PreMeFen (prehospitalario) encontró que el fentanilo intranasal no fue no inferior a los 10 minutos, aunque se igualó a los 20 y 30; Blancher (sufentanilo, n = 136) sí mostró no inferioridad a los 30 minutos. Los autores señalan que algunos ensayos sugieren un efecto más lento en los primeros 10 minutos.
- **La seguridad está lejos de demostrarse.** DATO DEL ARTÍCULO Eventos graves: RR 1.87 (0.97–3.59; p = 0.06). Bradipnea: RR 1.68 (0.58–4.88). Los autores piden ensayos mayores para eventos raros. INTERPRETACIÓN Estos intervalos son compatibles con no tener efecto, pero también con duplicar el riesgo. "No significativo" en eventos raros casi siempre significa "no hay poder para saberlo". La conclusión de "sin aumento claro de eventos sistémicos" debe leerse con esa reserva.
- **Mezcla de poblaciones y fármacos.** INTERPRETACIÓN Combina niños con fracturas, adultos con trauma en ambulancia y posoperatorio dental, con tres opioides y dosis distintas. La baja heterogeneidad estadística no garantiza que el resultado aplique igual en cada escenario. Además, los 2 ensayos de morfina intranasal usaron una formulación con quitosano en posoperatorio, uno usó un subgrupo post hoc de morfina IV y en otro los fármacos se dieron durante la cirugía. Para la práctica, la mejor evidencia es con fentanilo intranasal.

CONCEPTO CLAVE · DIFERENCIA DE MEDIAS ESTANDARIZADA Y EQUIVALENCIA

DME: cuando los estudios usan escalas distintas (EVA de 100 mm, numérica de 0 a 10), cada diferencia se divide entre la desviación estándar, y el resultado queda en "unidades de DE". Como referencia, 0.2 es pequeño, 0.5 moderado y 0.8 grande. Tiene un costo: se pierde la escala clínica, y no se puede decir directamente "cuántos puntos de dolor". **Superioridad vs. equivalencia:** un IC que cruza el 0 dice que no se demostró diferencia; para afirmar que son equivalentes, el IC completo debe quedar dentro de un margen fijado de antemano (por ejemplo, la diferencia mínima clínicamente importante). **Eventos raros:** con pocos eventos, el IC del RR es amplio; para descartar un aumento relevante de, por ejemplo, depresión respiratoria, se necesitan miles de pacientes o registros grandes.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Solo ECA	10 ECA, 8 con riesgo de sesgo bajo; resultados estables al quitar uno por uno.	Confirmado
● Sin heterogeneidad ni efecto de estudios pequeños	I^2 de 0 a 12 % en el desenlace principal; Doi/LFK sin asimetría a los 20 min (LFK 0.37), aunque con 5 estudios la prueba tiene poco poder.	Confirmado
● Pocos pacientes por desenlace	El desenlace principal se basa en 556 (20 min) y 406 (30 min) pacientes.	Parcialmente reconocido
● Heterogeneidad clínica	Adultos y niños, escenarios distintos, tres opioides y dosis variables.	Reconocido por los autores
● Datos aproximados	Valores extraídos de gráficas o convertidos desde medianas.	Reconocido por los autores
● Seguridad imprecisa	Eventos graves y respiratorios con IC amplios.	Reconocido por los autores
● Sin GRADE	No se calificó la certeza de la evidencia por desenlace.	No comentado

Pregunta de repaso: niño de 8 años con fractura desplazada de antebrazo en urgencias, dolor 9/10 y sin vía IV todavía. ¿Qué aporta este metaanálisis?
Respuesta. Que un opioide intranasal, sobre todo fentanilo, logra a los 20 y 30 minutos una analgesia comparable a la de la morfina IV, sin esperar la vía.[1] Hay que saber que el efecto puede tardar un poco más en los primeros 10 minutos y que la seguridad para eventos raros todavía es imprecisa. Por eso se mantienen la vigilancia de la frecuencia respiratoria y la saturación, la dosis por peso según el protocolo local y la analgesia multimodal.

¿Qué aprendí de medicina?

- Intranasal vs. morfina IV: sin diferencia demostrada a los 20 y 30 minutos.
- Útil sin vía IV: prehospitalario, niños, urgencias saturadas.
- Inicio quizá más lento en los primeros 10 minutos.
- Algo más de disgeusia (limítrofe); la seguridad en eventos raros sigue imprecisa.

¿Qué aprendí de investigación?

- DME: 0.2 pequeño, 0.5 moderado, 0.8 grande.
- No demostrar diferencia ≠ demostrar equivalencia.
- Cuenta cuántos pacientes respaldan cada desenlace.
- p = 0.06 en eventos graves no es tranquilizador.

6 Referencias

1. Fida L, Alahmed H, Almutairi AS, AlNassar SY, Alanazi SA, Martan R, Al Sagel A, Almojaly LS, et al. Comparative efficacy and safety of intranasal opioids vs. intravenous morphine for acute moderate-to-severe pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Emerg Med. 2026;91:158–172. doi:10.1016/j.jemermed.2026.09.021

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.